

//РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. АУТОПСИЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Организационно-методическое руководство патологоанатомической службой России осуществляет:

- {
- =Министр здравоохранения России
- =Главный внештатный патологоанатом Минздрава России
- =Председатель российского общества патологоанатомов
- =Начальник методического отдела Минздрава России
- =Заместитель министра здравоохранения России
- }

Организационно-методическое руководство патологоанатомической службой Республики Дагестан осуществляет:

- {
- =Министр здравоохранения России
- =Министр здравоохранения РД
- =Главный внештатный патологоанатом Минздрава РД
- =Председатель Дагестанского регионального отделения российского общества патологоанатомов
- =Заместитель министра здравоохранения РД
- }

Обязательному патологоанатомическому вскрытию подлежат дети, умершие в возрасте до:

- {
- =1 года
- =16 лет
- =28 дней жизни включительно
- =7 дней жизни включительно
- =13 дней жизни включительно
- }

В стационаре направление на патологоанатомическое вскрытие тел умерших организует:

- {
- =Заведующий того отделения, в котором наступила смерть больного

- =Заведующий того отделения, по нозологическому профилю которого наступила смерть больного
- =Главный врач
- =Заместитель главного врача по лечебной части
- =Медицинская сестра

}

Изучение медицинской документации патологоанатомом:

{

- =Производится перед началом проведения аутопсии
- =Производится в ходе проведения аутопсии
- =До аутопсии не требуется
- =Производится после начала проведения аутопсии
- =Производится в любом порядке

}

Патологоанатомическое вскрытие проводится в срок от момента констатации биологической смерти до:

{

- =12 часов
- =24 часов
- =До 2 суток
- =До 3 суток
- =До 5 суток

}

Признак патологоанатомического вскрытия 1 категории сложности:

{

- =Проводится без гистологического исследования
- =Проводится без извлечения органокомплекса
- =Производится только врачом 1 квалификационной категории
- =Производится без вскрытия полости черепа
- =Производится с гистологическим исследованием

}

Проведение патологоанатомического вскрытия возможно:

{

- =Сразу после констатации биологической смерти
- =Не ранее 3 часов после констатации смерти

=Не ранее 6 часов после констатации смерти
=При появлении ранних признаков смерти
=Не ранее 7 часов после констатации смерти
}

Патологоанатомическое вскрытие плода, мертворожденного имеет категорию сложности:

{
=Первую
=Вторую
=Третью
=Четвертую
=Пятую
}

Патологоанатомическое вскрытие при установленном клиническом диагнозе имеет категорию сложности:

{
=Первую
=Вторую
=Третью
=Четвертую
=Пятую
}

Патологоанатомическое вскрытие при полипатии имеет категорию сложности:

{
=Первую
=Вторую
=Третью
=Четвертую
=Пятую
}

Годовая нагрузка секционной работы на одну штатную должность врача патологоанатома общесоматического лечебно-профилактического учреждения составляет:

{
= 100 вскрытий

- = 140 вскрытий
- = 150 вскрытий
- = 200 вскрытий
- = 250 вскрытий

}

Годовая нагрузка секционной работы врача-патологоанатома детских патолого-анатомических отделений составляет:

{

- = 100 вскрытий
- = 140 вскрытий
- = 160 вскрытий
- = 200 вскрытий
- = 250 вскрытий

}

На выбор способа и порядка проведения патологоанатомического вскрытия трупа не влияют требования:

{

- = Эффективной и безопасной работы сотрудников патологоанатомического отделения
- = Исключение загрязнения окружающей среды
- = Полное исследование органов и систем умершего
- = Просьбы родственников умершего
- = Исключение действий, ведущих к обезображиванию трупа

}

Без согласия пациента или его законного представителя сведения, составляющие врачебную тайну, передаются должностным лицам в следующих ситуациях, кроме:

{

- = В целях обследования и лечения недееспособного гражданина
- = При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых поражений и отравлений
- = В случаях оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет
- = Для публикации в научной литературе, использования в учебном процессе
- = По запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда

}

В случаях диагностирования злокачественных опухолей, инфекционных заболеваний, заболеваний, требующих гормональной, лучевой, цитостатической терапии и хирургических вмешательств, патологогистологическое заключение подписывает:

- {
- = Врач-патологоанатом
- = Заведующий патологоанатомическим отделением
- = Главный врач
- = Лечащий онколог
- = Врач-патологоанатом и заведующий патологоанатомическим отделением
- }

В случаях диагностирования злокачественных новообразований, инфекционных заболеваний, заболеваний, требующих гормональной, лучевой, цитостатической терапии и хирургических вмешательств, заключение подписывает:

- {
- = Врач-патологоанатом
- = Зав. патологоанатомическим отделением
- = Главный врач больницы
- = Мед сестра
- = Лаборант
- }

При подозрении на наличие воздушной эмболии патологоанатомическое исследование начинают от:

- {
- = Вскрытия черепа
- = Вскрытия грудной клетки
- = Вскрытия брюшной полости
- = Вскрытия брюшной и грудной полостей
- = Вскрытия конечностей
- }

Разрез кожных покровов трупа, проходящий от подбородка или нижнего края щитовидного хряща до лобковой области, называют:

- {
- = По Абрикосову
- = По Лешке
- = Срединным

= По Фишеру
= По Самсонову
}

Годовая нагрузка секционной работы на одну штатную должность врача-патологоанатома общесоматического лечебно-профилактического учреждения составляет:

{
= 100 вскрытий
= 140 вскрытий
= 150 вскрытий
= 200 вскрытий
= 250 вскрытий
}

Полукружный разрез кожных покровов трупа, проходящий от одного акромиального отростка к другому, с дальнейшим продолжением его по срединной линии, называют:

{
=По Абрикосову
=По Лешке
=По Автандилову
=По Фишеру
=По Самсонову
}

Разрез кожных покровов, начинающийся за ухом у сосцевидного отростка височной кости, идущий по срединной линии и заканчивающийся ниже пупка двумя косыми, идущими к пупартовой связке, называют:

{
=По Абрикосову
=По Лешке
=Срединным
=По Фишеру
=По Самсонову
}

Перед фиксацией удаленного желчного пузыря необходимо:

{

=Удалить конкременты

=Вскрыть просвет

=Промыть полость проточной водой

=Промыть полость изотоническим раствором

=Промыть полость фиксирующей жидкостью

}

«Протокол патологоанатомического вскрытия плода, мертворожденного или новорожденного» имеет номер учетной формы:

{

=Форма №106-2/y

=Форма №13-1/y

=Форма №106/y

=Форма №13/y

=Форма №103/y

}

«Протокол патологоанатомического вскрытия» является приложением к действующему:

{

=Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 502н от 5 мая 2012 г. «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»

=Приказу Министерства здравоохранения РФ № 352н от 15 апреля 2021 г. «Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи»

=Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 782н от 26 декабря 2008 г. «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти»

=Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1687н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»

=Приказу Министерства здравоохранения РФ № 354н от 6 июня 2013 г. «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий»

}

В каких случаях патологоанатомическое вскрытие (аутопсию) можно не проводить:

{

=Смерть пациента в приемном покое с кровоизлиянием в левое полушарие головного мозга от отека головного мозга
=Смерть пациента с сахарным диабетом от ковидной пневмонии
=Смерть новорожденного
=Смерть пациента с низкодифференцированной аденокарциномой правого легкого от кахексии
=Смерть роженицы
}

Врач-патологоанатом осуществляет окончательное оформление протокола патологоанатомического вскрытия в срок:

{
=В день (в течение суток) проведения патологоанатомического вскрытия
=Через 14 дней после проведения патологоанатомического вскрытия
=Не позднее 30 суток после проведения патологоанатомического вскрытия
=Срок не ограничен
=Не позднее 20 суток после проведения патологоанатомического вскрытия
}

В чьи обязанности входит решение о выдаче тела умершего пациента родственникам без патологоанатомического вскрытия:

{
=В обязанности дежурного врача
=В обязанности главного врача
=В обязанности лечащего врача
=В обязанности заведующего клиническим отделением
=В обязанности заведующего патологоанатомическим отделением
}

Патологоанатомическое вскрытие (аутопсия) проводится в срок:

{
=12 часов
=24 часа
=до 2 суток
=До 3 суток
=До 4 суток
}

Нормативный срок завершения оформления протокола патологоанатомического вскрытия:

{
=7 дней
=14 дней
=30 дней
=60 дней
=70 дней
}

Протоколы патологоанатомических вскрытий хранятся:

{
=5 лет
=3 года
=1 месяц
=Бессрочно
=6 лет
}

//РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ О ДИАГНОЗЕ

Врач-патологоанатом осуществляет оформление и выдачу МСС с момента установления причины смерти:

{
=Через 14 дней после проведения патологоанатомического вскрытия
=В день (в течение суток) проведения патологоанатомического вскрытия
=Не позднее 30 суток после проведения патологоанатомического вскрытия
=Не позднее 20 суток после проведения патологоанатомического вскрытия
=Срок не ограничен
}

Нормативный срок регистрации «Медицинского свидетельства о смерти» в загсе (с момента обнаружения трупа или наступления смерти) – не позднее:

{
=Суток
=3 сут
=10 сут
=Месяца
=Год

}

Медицинский документ, удостоверяющий случай рождения:

{

= Медицинское свидетельство о рождении

= Свидетельство о рождении

= Справка о рождении

= История родов

= Карта новорожденного

}

Заполнение и выдача медицинского свидетельства о перинатальной смерти производится в:

{

= Мед. организации где произошла перинатальная смерть

= Патологоанатомическом отделении

= Бюро судебно-медицинской экспертизы

= Поликлинике

= Диспансере

}

Срок хранения корешков медицинских свидетельств о рождении и смерти:

{

= 1 год

= 2 года

= 3 года

= 5 лет

= 10 лет

}

Медицинское свидетельство о смерти «взамен предварительного» заполняется после установления причины смерти не позднее:

{

= 10 дней

= 25 дней

= 30 дней

= 45 дней

= 60 дней

}

Медицинское свидетельство о смерти «взамен окончательного» заполняется после установления причины смерти не позднее:

- {
- = 10 дней
- = 25 дней
- = 30 дней
- = 45 дней
- = 60 дней
- }

«Медицинское свидетельство о смерти» имеет номер учетной формы:

- {
- =Форма №13/у
- =Форма №103/у
- =Форма №106/у
- =Форма №13-1/у
- =Форма №106-2/у
- }

Медицинское свидетельство о смерти оформляется в следующих случаях:

- {
- =После судебно-медицинского вскрытия
- =После патологоанатомического вскрытия
- =На основании предшествовавшего наблюдения за пациентом
- =На основании постановления прокуратуры
- =На основании осмотра трупа и записи в медицинской документации
- }

В какую строку МСПС указывается основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка:

- {
- =а)
- =г)
- =б)
- =д)
- =в)
- }

В какую строку МСС указывается сопутствующее заболевание:

{
=I г)
=I а)
=II
=I в)
=I б)
}

В какую строку МСС указывается непосредственная причина смерти:

{
=I г)
=I в)
=II
=I а)
=I б)
}

В какую строку МСС указывается фоновое заболевание:

{
=I в)
=II
=I г)
=I б)
=I а)
}

В какую строку МСС указывается первоначальная причина смерти (основное заболевание):

{
=I б)
=I в)
=II
=I г)
=I а)
}

Какой из перечисленных вариантов не относится к видам смерти:

{

- = Биологическая
- = Насильственная
- = Смерть, вызванная болезнью
- = Внутритрубная
- = Патологическая

}

Биологическая смерть это:

{

- = Полное и необратимое прекращение жизненных функций организма и прежде всего систем, регулирующих эти функции
- = Смерть, наступившая в результате каких-либо насильственных действий извне (несчастные случаи, травма, убийство, самоубийство, отравление)
- = Полное, но обратимое прекращение жизненных функций организма и прежде всего систем, регулирующих эти функции
- = Смерть среди видимого здоровья, неожиданная для окружающих, при отсутствии у умершего очевидных проявлений смертельного заболевания
- = Неполное и обратимое прекращение жизненных функций организма и прежде всего систем, регулирующих эти функции

}

Своевременное установление клинического диагноза при плановой госпитализации осуществляется:

{

- = Незамедлительно
- = В срок до 3 суток
- = В срок до 5 суток
- = В срок до 7 суток
- = В срок до 10 суток

}

Своевременное установление клинического диагноза при ургентной госпитализации осуществляется:

{

- = Незамедлительно
- = В срок до 3 суток
- = В срок до 5 суток
- = В срок до 7 суток
- = В срок до 10 суток

}

Ятрогения в заключительном клиническом и патологоанатомическом диагнозах не может быть в составе:

{

= Основного заболевания

= Сопутствующего заболевания

= Осложнения основного заболевания

= Конкурирующего заболевания

= Сочетанного заболевания

}

Сколько времени корешки медицинских свидетельств подлежат хранению по месту их выдачи:

{

= в течение 1 года

= в течение 1 месяца

= в течение 5 лет

= в течение 10 лет

= в течение 15 лет

}

В патологоанатомическом диагнозе ятрогении I категории занимают место в рубрике:

{

= основного заболевания

= сопутствующего заболевания

= фонового заболевания

= конкурирующих заболеваний

= осложнения основного заболевания

}

В патологоанатомическом диагнозе ятрогении III категории занимают место в рубрике:

{

= основного заболевания

= сопутствующего заболевания

= фонового заболевания

= конкурирующих заболеваний

= осложнения основного заболевания

}

Патологоанатомический диагноз начинают:

{

=С нозологической единицы («ключевого слова», единицы статистического, учета) основного заболевания - первоначальной причины смерти

=С непосредственной причины смерти

=С патологического процесса, запустившего патогенетическую цепь

=С патологического процесса и непосредственной причины смерти

=С патогенетической цепи

}

Непосредственная причина смерти – это:

{

=Нозологическая единица (синдром, травма), за которой последовала биологическая смерть

=Нозологическая единица, явившаяся причиной танатогенетического процесса

=Механизм наступления смерти

=Нозологическая единица и механизм наступления смерти

=Танатогенетический процесс

}

Нозологическая единица (болезнь, травма), имеющая в данный момент наиболее выраженные проявления, угрожающие здоровью и жизни больного, по поводу которого проводится лечение – это:

{

=Фоновое заболевание

=Конкурирующее заболевание

=Основное заболевание

=Сопутствующее заболевание

=Сочетанное заболевание

}

С социальных позиций болезнь – это:

{

=Это неустойчивая форма жизнедеятельности организмов вследствие генетического дефекта или воздействия повреждающего фактора внешней среды

=Неустойчивая форма жизнедеятельности организмов вследствие генетического дефекта или воздействия повреждающего фактора внешней среды

=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом

=Конкретное, определенное заболевание, обозначаемое в научной медицине термином нозологическая форма

=Неспособность в полной мере удовлетворять свои материальные и духовные потребности

}

С клинических, медико-статистических позиций болезнь – это:

{

=Неустойчивая форма жизнедеятельности организмов вследствие генетического дефекта или воздействия повреждающего фактора внешней среды

=Неспособность в полной мере удовлетворять свои материальные и духовные потребности

=Конкретное, определенное заболевание, обозначаемое в научной медицине термином нозологическая форма

=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом

=Это неустойчивая форма жизнедеятельности организмов вследствие генетического дефекта или воздействия повреждающего фактора внешней среды

}

Две одновременно имеющиеся у больного нозологические единицы, каждая из которых в отдельности могла бы привести к смерти – это:

{

=Конкурирующие заболевания

=Сочетанные заболевания

=Полипатии

=Основное и фоновое заболевания

=Основное и сопутствующее заболевания

}

Дайте определение понятию «Патологическое состояние»:

{

- =Совокупность патологических, компенсаторных и приспособительных реакций на действие патогена
- =Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом
- =Медленно протекающий патологический процесс, сопровождающийся стойкими и длительными нарушениями в организме
- =Специфическая комбинация симптомов
- =Кратковременная реакция организма на действие раздражителя

}

Дайте определение понятию «Патологическая реакция»:

{

- =Кратковременная реакция организма на действие раздражителя
- =Совокупность патологических, компенсаторных и приспособительных реакций на действие патогена
- =Медленно протекающий патологический процесс, сопровождающийся стойкими и длительными нарушениями в организме
- =Специфическая комбинация симптомов
- =Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом

}

Нозологическая форма, которая играет существенную роль в возникновении и развитии основного заболевания, хотя этиология у него иная, ускоряет и утяжеляет танатогенез – это:

{

- =Сочетанное заболевание
- =Конкурирующее заболевание
- =Непосредственная причина смерти
- =Сопутствующее заболевание
- =Фоновое заболевание

}

Дайте определение понятию «Патологический процесс»:



— пат со с

{

=Медленно протекающий патологический процесс, сопровождающийся стойкими и длительными нарушениями в организме

=Специфическая комбинация симптомов — синдром

=Совокупность патологических, компенсаторных и приспособительных реакций на действие патогена — пат реакция

=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом

=Кратковременная реакция организма на действие раздражителя

}

С медико-биологической позиции болезнь — это:

{

=Неспособность в полной мере удовлетворять свои материальные и духовные потребности

=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с общей этиологией и патогенезом

=Неустойчивая форма жизнедеятельности организмов вследствие генетического дефекта или воздействия повреждающего фактора внешней среды

=Конкретное, определенное заболевание, обозначаемое в научной медицине термином нозологическая форма

=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом

}

Что такое «нозологическая форма»:

{

=Неспецифическая комбинация симптомов

=Специфическая комбинация симптомов

=Это совокупность клинических, лабораторных и инструментальных, диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом

=Медицинское заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об имеющемся заболевании или о причине смерти, выраженное в терминах, предусмотренных принятыми классификациями и номенклатурой болезней

=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом

}

Нозологическая единица, которая этиологически и патогенетически не связана с основным заболеванием и его осложнениями, не оказало на их течение и развитие неблагоприятного влияния и не способствовало наступлению смерти – это:

{

=Непосредственная причина смерти

=Сочетанное заболевание

=Сопутствующее заболевание

=Фоновое заболевание

=Конкурирующее заболевание

}

Две нозологические единицы, случайно совпавшие во времени и топике, каждая из которых в отдельности в данных условиях не могла привести к смерти, но в совокупности они взаимно утяжеляют течение друг друга и становятся причиной смерти – это:

{

=Конкурирующие заболевания

=Основное и сопутствующее заболевания

=Основное и фоновое заболевания

=Полипатии

=Сочетанные заболевания

}

Что такое «синдром»:

{

=Специфическая комбинация симптомов

=Неспецифическая комбинация симптомов

=Это совокупность клинических, лабораторных и инструментальных, диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом

=Медицинское заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об имеющемся заболевании или о причине смерти, выраженное в терминах, предусмотренных принятыми классификациями и номенклатурой болезней

=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом

}

Основное заболевание: Рак нижне-ампулярного отдела прямой кишки pT3N1M0.

Конкурирующее заболевание: Сахарный диабет 2 типа. Осложнения: 1. Хроническая сердечная недостаточность. 2. Ишемический инфаркт теменной, затылочной долей и подкорковых ядер головного мозга справа. 3. Отек головного мозга.

Сопутствующее заболевание: Псориаз. В какой строке МСС следует указать сахарный диабет 2 типа:

{

=I б)

=I в)

=I а)

=II

=I г)

}

1. а) отек
б) сд зт

2. рак

Основное заболевание: Расслаивающая мешковидная атеросклеротическая аневризма восходящего отдела аорты с разрывом (линейный разрыв 1,5 см). Фоно-

вое заболевание: Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. Осложнения: 1. Хроническая застойная сердечная недостаточность. 2.

Гемотампонада сердца. Сопутствующее заболевание: Хронический интерстициальный нефрит. В какой строке МСС следует указать гемотампонаду сердца:

{

=I а)

=II

=I г)

=I б)

=I в)

}

Основное заболевание: Расслаивающая мешковидная атеросклеротическая аневризма восходящего отдела аорты с разрывом (линейный разрыв 1,5 см). Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. Осложнения: 1. Хроническая застойная сердечная недостаточность. 2. Гемотампонада сердца. Сопутствующее заболевание: Хронический интерстициальный нефрит. В какой строке МСС следует указать гипертоническую болезнь:

- {
- =I г)
- =I б)
- =II
- =I в)
- =I а)
- }

Основное заболевание: Расслаивающая мешковидная атеросклеротическая аневризма восходящего отдела аорты с разрывом (линейный разрыв 1,5 см). Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. Осложнения: 1. Хроническая застойная сердечная недостаточность. 2. Гемотампонада сердца. Сопутствующее заболевание: Хронический интерстициальный нефрит. В какой строке МСС следует указать мешковидную атеросклеротическую аневризму аорты с разрывом:

- {
- =I б)
- =I а)
- =I в)
- =II
- =I г)
- }

Основное заболевание: Рак ниже-ампулярного отдела прямой кишки рТ3N1M0. Конкурирующее заболевание: Сахарный диабет 2 типа. Осложнения: 1. Хроническая сердечная недостаточность. 2. Ишемический инфаркт теменной, затылочной долей и подкорковых ядер головного мозга справа. 3. Отек головного мозга. Сопутствующее заболевание: Псориаз. В какой строке МСС следует указать ишемический инфаркт головного мозга:

- {
- =I в)
- =I а)
- =II

=I б)

=I г)

}

Основное заболевание: Рак ниже-ампулярного отдела прямой кишки рТ3N1M0.
Конкурирующее заболевание: Сахарный диабет 2 типа. Осложнения: 1. Хроническая сердечная недостаточность. 2. Ишемический инфаркт теменной, затылочной долей и подкорковых ядер головного мозга справа. 3 . Отек головного мозга.
Сопутствующее заболевание: Псориаз. В какой строке МСС следует указать рак прямой кишки:

{

=II

=I г)

=I а)

=I в)

=I б)

}

В любой рубрике диагноза недопустимо использовать некорректный термин:

{

= ювенильный ревматоидный артрит

= прогрессирующий атеросклероз аорты

= коронарокардиосклероз

= крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз

= хроническая аневризма сердца

}

В случаях анафилактического шока и смерти во время наркоза и анестезии при правильных, по показаниям проведенных диагностических, лечебных, реанимационных и реабилитационных мероприятиях ятрогенная патология регистрируется в рубрике:

{

= осложнения основного заболевания

= основное заболевание

= сопутствующие заболевания

= второе конкурирующее заболевание

= второе сочетанное заболевание

}

Ятрогенное заболевание 1 группы указывается в 22 пункте МСС в строке:

{
=I а)
=I г)
=I б)
=II
=I в)
}

Ятрогенное заболевание 1 группы является:

{
=Основным заболеванием
=Сопутствующим заболеванием
=Конкурирующим заболеванием
=Фоновым заболеванием
=Сочетанным заболеванием
}

Нозологическая форма, однозначно обусловленная медицинским вмешательством, не связанная патогенетически с основным заболеванием или его осложнением и не играющие существенной роли в танатогенезе – это:

{
=3 категория расхождения
=3 группа ятрогений
=2 категория расхождения
=1 группа ятрогений
=2 группа ятрогений
}

Ятрогенное заболевание 3 группы является:

{
=Конкурирующим заболеванием
=Сочетанным заболеванием
=Фоновым заболеванием
=Основным заболеванием
=Сопутствующим заболеванием
}

Ятрогенное заболевание 3 группы указывается в 22 пункте МСС в строке:

{
=I б)
=I в)
=II
=I г)
=I а)
}

Ятрогенное заболевание 2 группы указывается в 22 пункте МСС в строке:

{
=I б)
=I г)
=I а)
=II
=I в)
}

Нозологическая форма, однозначно обусловленная медицинскими воздействиями (типа случайного нанесения вреда пациенту в ходе их выполнения, несчастных случаев, аномальных реакций и т.п.) и являющиеся причиной летального исхода – это:

{
=3 категория расхождения
=1 группа ятрогений
=2 группа ятрогений
=2 категория расхождения
=3 группа ятрогений
}

Нозологическая форма, обусловленная медицинским воздействием, чаще проведенным обоснованно и технологически правильно (развитие их в большинстве случаев связано с индивидуальными особенностями организма) и играющие существенную роль в танатогенезе – это:

{
=2 группа ятрогений
=2 категория расхождения
=1 категория расхождения
=1 группа ятрогений
=3 группа ятрогений

}

Заболевание не было распознано в данном лечебном учреждении, неправильная диагностика повлекла за собой ошибочную лечебную тактику, что сыграло решающую роль в смертельном исходе – это:

{

=3 группа ятрогений

=2 группа ятрогений

=2 группа ятрогений

=1 группа ятрогений

=3 группа ятрогений

}

//РАЗДЕЛ 3. КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Заболевание не было распознано на предыдущих этапах диагностики и лечения, а в данном лечебном учреждении установление правильного диагноза было невозможно из-за объективных трудностей – это:

{

=2 категория расхождения

=3 категория расхождения

=1 группа ятрогений

=1 категория расхождения

=2 группа ятрогений

}

В клинико-патологоанатомическом эпикризе не отражается:

{

=Обоснование диагноза основного заболевания

=Углубленная интранозологическая характеристика основного заболевания, его особенности, включая патоморфоз

=Непосредственная причина смерти, ее механизм или вид

=Обсуждение осложнений лечебных и диагностических мероприятий, их роль в танатогенезе

=Суждение о виновности медицинского персонала в неблагоприятном исходе заболевания

}

На комиссиях по изучению летальных исходов подлежат разбору:

{
=Все случаи летальных исходов
=Ятрогении
=Сложные для диагностики случаи
=Случаи системных ошибок диагностики
=Системные ошибки с ятрогениями
}

На клинико-анатомических конференциях подлежат разбору:

{
=Все случаи летальных исходов
=Ятрогении
=Сложные для диагностики случаи
=Случаи системных ошибок диагностики
=Системные ошибки с ятрогениями
}

Задачей КИЛИ не является:

{
=установление причины смерти
=установление категории расхождения диагнозов
=контроль качества ведения медицинской документации
=установление причины диагностических ошибок
=привлечение к дисциплинарной ответственности
}

В обязательный состав КИЛИ не входит:

{
=Председатель
=Секретарь
=Рецензент
=Оппонент
=Члены кили
}

Предметом анализа летальных исходов на ЛКК не является:

{
=Ятрогенные осложнения
=Диагностические ошибки при ургентной патологии
}

- =Расхождения диагнозов III категории
- =Расхождения диагнозов I-II категории
- =Случаи, вынесенные кили на ЛКК

}

К этапам коллегиального анализа летальных исходов в лечебно-профилактическом учреждении не относится:

{

- =Проведение клинико-морфологических сопоставлений, анализа качества оказания медицинской помощи с участием лечащего врача у секционного стола.
- =Контроль заведующего патологоанатомическим отделением за соблюдением стандартов патологоанатомической диагностики и экспертизы врачами отделения.
- =Обсуждение всех случаев летального исхода на заседаниях комиссии по изучению летальных исходов ЛПУ.
- =Углубленный анализ сложных и спорных случаев ЛКК больницы.
- =Углубленный разбор наиболее сложных и спорных случаев на клинико-анатомических конференциях.

}

На основе клинико-морфологического анализа патологоанатом заполнил строчки пункта 18 «Медицинского свидетельства о смерти» мужчины 55 лет: а. Фибрилляция желудочков; б. Острый трансмуральный инфаркт переднебоковой стенки левого желудочка (рубрика 121.2). Где следует отразить выявленный стенозирующий атеросклероз венечных артерий сердца:

{

- =Строчка «в» I части
- =Строчка «г» I части
- =Строчки II части
- =Не вносить в разделы пункта
- =Все вносить

}

Больной 17 лет, заболел остро. Жалобы на слабость, недомогание, головные боли, болезненность и увеличение лимфатических узлов шеи, повышение температуры до 38 градусов. Лимфатические узлы плотные, болезненные при пальпации. Больному следует рекомендовать:

{

- = обследование, наблюдение

- = пункцию лимфатического узла
- = биопсию лимфатического узла
- = физиотерапию
- = электротерапию

}

Причиной смерти 35-летнего наркомана, страдавшего ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа, явился милиарный туберкулез с развитием лептоменингита. В заключительном клиническом и патологоанатомическом диагнозах туберкулез расценивается как:

{

- =Основное заболевание.
- =Сопутствующее заболевание.
- =Конкурирующее заболевание.
- =Сочетанное заболевание.
- =Осложнение ВИЧ-инфекции.
- =Проявление ВИЧ-инфекции.

}

При подготовке и проведении очередной клинико-анатомической конференции главный врач ЛПУ не исходит из следующей методической рекомендации:

{

- =Подготовка и организация конференций возлагаются на заместителя главного врача по медицинской части и заведующего патологоанатомическим отделением, они же назначаются председателями конференции.
- =Сопредседатели конференции определяют повестку конференции и доводят ее в письменном виде до сведения врачей учреждения не позднее чем за 7 дней до начала конференции.
- =Основными докладчиками на конференции являются лечащий врач, патологоанатом и рецензент, назначенный из числа наиболее квалифицированных врачей-клиницистов.
- =Каждая конференция должна сопровождаться обзором современной литературы по анализируемой проблеме и проходить в атмосфере критического подхода к разбираемому материалу.
- =Клинико-анатомическая конференция проводится в нерабочее время, участие в ее работе не относится к функциональным обязанностям врачей данного ЛПУ.

}

К этапам клинико-анатомической конференции не относится:

{
=клиническая часть
=выступление патологоанатома
=выступление заведующего клиническим отделением
=выступление рецензента
=заключение председателя
}

КИЛИ создаются:

{
=Во всех медицинских организациях
=Только в многопрофильных стационарах
=Только в узкопрофильных стационарах
=В амбулаторных медицинских организациях
=В поликлинических медицинских организациях
}

ЛКК создаются:

{
=Во всех медицинских организациях
=Только в многопрофильных стационарах
=Только в узкопрофильных стационарах
=В амбулаторных медицинских организациях
=В поликлинических медицинских организациях
}

Комбинированное основное заболевание – это:

{
=Конкурирующие заболевания
=Основное и сопутствующее заболевания
=Полипатия
=Сочетание двух ведущих страданий у больного, эти болезни вызывают новое патологическое состояние и, взаимодействуя между собой, приводят к смерти
=Основное и фоновое заболевания
}

Вариантом комбинированного основного заболевания является:

{
=Конкурирующие заболевания

- =Альтернативные заболевания
- =Содружественные заболевания
- =Совместные заболевания
- =Скрытые заболевания

}

Объективной причиной расхождения диагнозов является:

{

- =отсутствие рентгенологического кабинета
- =пребывание в стационаре до 24 часов
- =пребывание в стационаре до 48 часов
- =кратковременность пребывания больного в стационаре
- =долговременность пребывания больного в стационаре

}

III категория расхождения заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов по основному заболеванию означает следующее:

{

- =Заболевание не распознано на предыдущем этапе оказания медицинской помощи, а в этом учреждении установление правильного диагноза было невозможно из-за объективных трудностей (смерть в приемном покое и т.д.).
- =Не распознавание заболевания привело к ошибочной лечебной тактике, что сыграло решающую роль в неблагоприятном исходе.
- =Заболевание не распознано в данном лечебном учреждении по субъективным причинам, однако диагностическая ошибка не оказала решающего влияния на исход болезни.
- =Заболевание не распознано в данном учреждении по объективным причинам, однако правильная диагностика не оказала бы решающего влияния на исход болезни.
- =Распознавание заболевания привело к ошибочной лечебной тактике, что сыграло решающую роль в неблагоприятном исходе

}

Субъективные причины расхождения диагнозов включают в себя всё, кроме:

{

- = недостаточного обследования больного
- = недоучета анамнестических данных
- = недоучета клинических данных
- = кратковременности пребывания больного в медицинском учреждении

= долговременности пребывания больного в медицинском учреждении
}

Объективные причины расхождения диагнозов включают в себя:

{
= тяжесть состояния больного
= недостаточное обследование больного
= недоучет анамнестических данных
= недоучет клинических данных
= недоучет клинико-анамнестических данных
}

К какой категории относится случай расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, если Заболевание не было распознано в данном лечебном учреждении, однако своевременная диагностика не оказала бы положительного влияния на исход заболевания, однако правильный диагноз мог быть поставлен:

{
= 1 категория
= 2 категория
= 3 категория
= 4 категория
= 5 категория
}

К какой категории относится случай расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, если Заболевание не было распознано на предыдущих этапах, а в данном лечебно-профилактическом учреждении установление правильного диагноза было невозможно из-за объективных причин:

{
= 1 категория
= 2 категория
= 3 категория
= 4 категория
= 5 категория
}

К какой категории относится случай расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, если Неправильная диагностика повлекла за собой ошибочную врачебную тактику, что сыграло решающую роль в смертельном исходе:

- {
- = 1 категория
- = 2 категория
- = 3 категория
- = 4 категория
- = 5 категория
- }

Признаками расхождения диагнозов третьей категории являются:

- {
- =Объективные трудности диагностики
- =Субъективные трудности диагностики
- =Дефект диагностики на предыдущем этапе обращения
- =Летальный исход не связан с ошибкой диагностики
- =Летальный исход связан с ошибкой диагностики
- }

«Правильный диагноз в данном лечебном учреждении был возможен, но основное заболевание не распознано в связи объективными или субъективными причинами, однако ошибка диагностики существенно не повлияла на исход болезни» - это расхождение:

- {
- = I категории
- = II категории
- = III категории
- = IV категории
- = V категории
- }

Заболевание не было распознано в данном лечебном учреждении, при этом правильная диагностика в связи с необратимостью изменений в организме не оказала бы решающего влияния на исход заболевания; однако правильный диагноз мог и должен был быть установлен – это:

- {
- =3 группа ятрогений
- =2 группа ятрогений
- =3 категория расхождения
- =1 категория расхождения
- =2 категория расхождения

}

Имеется статистически достоверное различие между приводимыми ниже процентными показателями числа расхождений между основными клиническими и патологоанатомическими диагнозами:

{

= 14 + 1% и 16 + 2%

= 15 + 1% и 17 + 12%

= 12 + 1% и 17 + 2%

= 13 + 1% и 16 + 2%

= 16 + 1% и 18 + 11%

}

Понятие «врачебная ошибка» включает все перечисленные ниже положения, за исключением:

{

= Некачественное оказание медицинской помощи (дефекты диагностики, лечения и т.д.), приведшее к ухудшению состояния здоровья пациента, вне зависимости от причин дефектов профессиональной деятельности

= Некачественное оказание медицинской помощи, которое могло привести к ухудшению состояния здоровья больного, вне зависимости от причин дефектов профессиональной деятельности

= Дефекты оказания медицинской помощи, возникшие по объективным и субъективным причинам, обусловившие наступление смертельного исхода

= Дефекты оказания медицинской помощи вне зависимости от их причины, которые могли повлиять на наступление смертельного исхода

= Некачественное оказание медицинской помощи, ведущие к ухудшению состояния здоровья пациента, при исключении в действиях медицинских работников элементов противоправности и виновности

}

Выберите объективные причины врачебных ошибок:

{

= Кратковременность пребывания больного в стационаре

= Дефекты лабораторных, аппаратных, инструментальных и др. исследований

= Сложность и недостаточная изученность заболевания

= Недооценка или переоценка роли консультантов

= Неправильная формулировка заключительного диагноза

}

ДОМП, имеющий в своей основе объективные причины: добросовестное заблуждение врача из-за атипичного течения болезни, кратковременного пребывания в ЛПУ, тяжести состояния пациента – это:

{
=Поздняя госпитализация
=Ятрогенные заболевания
=Несчастный случай
=Врачебная ошибка
=Медицинский деликт
}

ДОМП, обусловленный случайным стечением обстоятельств, которые нельзя было избежать, при наличии форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы – это:

{
=Медицинский деликт
=Поздняя госпитализация
=Несчастный случай
=Ятрогенные заболевания
=Врачебная ошибка
}

ДОМП - действие и/или бездействие, приносящие вред здоровью или жизни пациента и имеющее причинно-следственную связь между действием (бездействием) медработника и наступлением вреда:

{
=Ятрогенные заболевания
=Медицинский деликт
=Несчастный случай
=Врачебная ошибка
=Поздняя госпитализация
}

//РАЗДЕЛ 4. БИОПСИЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Годовая нагрузка врача-патологоанатома, выполняющего только исследование биопсий, составляет:

{

- = 1000 биопсий
- = 2000 биопсий
- = 3000 биопсий
- = 4000 биопсий
- = 5000 биопсий

}

Одно вскрытие умершего взрослого по рабочему времени эквивалентно исследованию следующего количества биопсий:

{

- = 10
- = 15
- = 20
- = 25
- = 30

}

Одно вскрытие мертворожденного, умершего новорожденного и ребенка эквивалентно по рабочему времени исследования следующему количеству биоптатов:

{

- = 10
- = 15
- = 20
- = 25
- = 30

}

Для полноценной морфологической диагностики заболеваний лечащий врач не обязан обеспечивать:

{

- = Маркировку объектов исследования
- = Фиксацию объектов исследования
- = Указание точного количества объектов
- = Заполнение в двух экземплярах направления на гистологическое исследование (форма № 14/у)
- = Визу главного врача (или его заместителя по лечебной части) на исследование

}

В направлении на гистологическое исследование диагностического соскоба эндометрия врач-гинеколог не указывает:

{

= Развернутый клинический диагноз

= Результаты и координаты предыдущих гистологических исследований

= Дату начала и окончания последней менструации или кровотечения

= Характер нарушения менструальной функции

= Национальность женщины

}

Интраоперационное (срочное) гистологическое исследование должно быть проведено в течение:

{

= До 20-25 мин

= До 1 ч

= В пределах 5 сут

= До 10 сут

= До 20-30 сут

}

Биопсия – это:

{

= Морфологическое исследование органокомплексов, органов (или их части), тканей, полученные при различных вариантах оперативного вмешательства

= Морфологическое исследование прижизненно иссеченных или изъятых другим способом тканей и частей органов

= Патологоанатомическое вскрытие

= Морфологическое исследование органа, связывающего плод с организмом матери

= Судебно-медицинское вскрытие

}

Пайпель-биопсия – это:

{

= Кюретаж-биопсия

= Пункционная биопсия

= Трепанобиопсия

= Аспирационная биопсия

= Эксцизионная биопсия

}

Исследование последа – это:

{

=Морфологическое исследование органокомплексов, органов (или их части), тканей, полученные при различных вариантах оперативного вмешательства

=Судебно-медицинское вскрытие

=Морфологическое исследование прижизненно иссеченных или изъятых другим способом тканей и частей органов

=Морфологическое исследование органа, связывающего плод с организмом матери

=Патологоанатомическое вскрытие

}

Временные затраты на патологоанатомическое вскрытие мертворожденного, умершего новорожденного и ребенка сопоставимы временным затратам, необходимым на исследование:

{

= 26-29 биоптатов

= 25-32 биоптатов

= 20 биоптатов

= 10-25 биоптатов

= 25 биоптатов

}

Выберите пример окончательного патогистологического заключения:

{

=В срезах лимфатического узла имеются эпителиоидно-клеточные гранулемы без признаков некроза, характерные для туберкулеза и саркоидоза

=В объеме исследуемого биоптата пласт зрелого многослойного плоского эпителия без подлежащей основы

=Тубулярная аденома легкой степени клеточной дисплазии в гиперпластическом полипе толстой кишки

=В представленном материале скопления эритроцитов, слизи, гранулоцитов, обрывки железистого эпителия

=Железистый полип цервикального канала

}

У 40-летнего мужчины в области келоидного рубца голени появилось изъязвление. Больной в течение 2 мес применял антисептические мазевые повязки без эффекта. Хирургом для установления природы заболевания направлен на гистологическое исследование иссеченный кусочек ткани из хронической язвы голени. Заключение патологоанатома: в доставленном материале мелкозернистые эозинофильные массы детрита с небольшими группами разрушенных нейтрофильных лейкоцитов. Характер патологоанатомического заключения:

- {
- =Окончательный диагноз
- =Ориентировочный диагноз
- =Описательный ответ
- =Предварительный диагноз
- =Ориентировочно-окончательный диагноз
- }

Окраска пикрофуксином по ван Гизону для выявления соединительной ткани – это:

- {
- =Микроскопический метод
- =Молекулярно-биологический метод
- =Бактериоскопический метод
- =Иммуногистохимический метод
- =Гистохимический метод
- }

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки – это:

- {
- =Эндоскопическая биопсия
- =Трепанобиопсия
- =Кюретаж-биопсия
- =Аспирационная биопсия
- =Интраоперационная биопсия
- }

Для правильной фиксации фрагментов органов и тканей используют:

- {
- =10% раствор формалина
- =Изопропиловый спирт

=1% раствор перекиси водорода
=40% раствор формалина
=70% этиловый спирт
}

Биологические материалы, полученные при проведении патологоанатомических вскрытий, фиксированные формалином хранятся

{
=30 дней
=До установления патологоанатомического диагноза
=3 года
=До оформления протокола патологоанатомического вскрытия
=4 года
}

Биологические материалы, полученные при проведении патологоанатомических вскрытий, в парафиновых блоках хранятся:

{
=3 месяца
=1 год
=3 года
=Бессрочно
=5 лет
}

Гистологические препараты, приготовленные из материала патологоанатомических вскрытий, хранятся:

{
=3 месяца
=1 год
=3 года
=бессрочно
=5 лет
}

Окраска метиленовым синим для выявления *Helicobacter pylori* – это:

{
=Молекулярно-биологический метод
=Бактериоскопический метод

=Иммуногистохимический метод
=Микроскопический метод
=Гистохимический метод
}

Биопсия, при которой иссекается вся опухоль в пределах здоровых тканей – это:
{
=Эндоскопическая биопсия
=Аспирационная биопсия
=Инцизионная биопсия
=Эксцизионная биопсия
=Пункционная биопсия
}

Фиброгастродуоденоскопия с забором фрагмента желудка – это:
{
=Эндоскопическая биопсия
=Аспирационная биопсия
=Пункционная биопсия
=Инцизионная биопсия
=Эксцизионная биопсия
}

Выберите пример ориентировочного патогистологического диагноза:
{
=В представленном материале скопления эритроцитов, слизи, гранулоцитов, обрывки железистого эпителия
=В срезах лимфатического узла имеются эпителиоидно-клеточные гранулемы без признаков некроза, характерные для туберкулеза и саркоидоза
=Субмукозная миома тела матки
=В представленном материале крайне скудный фрагмент покровного желудочного эпителия
=Тубулярная аденома легкой степени клеточной дисплазии в гиперпластическом полипе толстой кишки
}

Биопсия, при которой иссекается только часть новообразования (в центре или по периферии опухоли с захватом неповрежденной ткани) – это:
{

- =Кюретаж-биопсия
- =Интраоперационная биопсия
- =Инцизионная биопсия
- =Трепанобиопсия
- =Эксцизионная биопсия

}

Результат морфоклинических сопоставлений, заключение о верификации у пациента конкретной болезни (нозологической формы), с выделением ее клинικο-морфологического варианта, особенностей течения – это:

{

- =Окончательное патогистологическое заключение
- =Описательный ответ патологоанатома
- =Предварительный патологоанатомический диагноз
- =Заключительный клинический диагноз
- =Ориентировочный патогистологический диагноз

}

Исследование операционного материала – это:

{

- =Морфологическое исследование органокомплексов, органов (или их части), тканей, полученные при различных вариантах оперативного вмешательства
- =Морфологическое исследование органа, связывающего плод с организмом матери
- =Морфологическое исследование прижизненно иссеченных или изъятых другим способом тканей и частей органов
- =Патологоанатомическое вскрытие
- =Судебно-медицинское вскрытие

}

Позволяет сделать вывод о характере общепатологического процесса (вид воспаления, некроза) – это:

{

- =Предварительный патологоанатомический диагноз
- =Заключительный клинический диагноз
- =Описательный ответ патологоанатома
- =Окончательное патогистологическое заключение
- =Ориентировочный патогистологический диагноз

}

Результат морфологического исследования, который позволяет патологоанатому ограничить круг заболеваний при проведении дифференциальной диагностики – это:

- {
- =Предварительный патологоанатомический диагноз
- =Окончательное патогистологическое заключение
- =Заключительный клинический диагноз
- =Описательный ответ патологоанатома
- =Ориентировочный патогистологический диагноз
- }

Фиксирующий раствор для консервации биопсийного (операционного) материала в целях последующего иммуногистохимического исследования:

- {
- =раствор формальдегида 4% на 5% фосфатном буфере, забуференный при pH 6,8-7,4
- =раствор формальдегида 10% на 10% фосфатном буфере, забуференный при pH 6,8-7,4
- =спирт этиловый 70% на 5% фосфатном буфере, забуференный при pH 6,8-7,4
- =раствор формальдегида 4% на 5% фосфатном буфере, забуференный при pH 7,5-8,5
- =раствор формальдегида 10% на 5% фосфатном буфере, забуференный при pH 6,8-7,4
- }

Застывший парафин в качественном блоке:

- {
- = может иметь трещины
- = с белесоватым ореолом вокруг кусочка ткани
- = может иметь сколы
- = содержит пузырьки
- = однороден
- }

Метод используемый при необходимости срочного исследования эндоскопических биопсий, рыхлых, ослизненных, жировой и костной тканей:

- {
- = электронная микроскопия

- = иммуногистохимия
- = гистологический
- = цитологический
- = ПЦР

}

Если размеры операционного материала не позволяют погрузить его в имеющиеся контейнеры с фиксирующей жидкостью – такой материал следует доставить в патологоанатомическое отделение в течении:

{

- = 2 суток
- = 1 суток
- = 10 часов
- = 5 часов
- = немедленно после иссечения

}

Метод молекулярной патологии:

{

- = гистохимическое исследование
- = полимеразная цепная реакция
- = проточная цитофотометрия
- = метод клеточных и тканевых культур
- = гистофотометрия

}

//РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. АУТОПСИЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Функции патологоанатомической службы:

{

- =Экспертно-диагностическая
- =Организационно-правовая
- =Информационно-статистическая
- =Учебно-педагогическая
- =Юридическая
- =Научно-исследовательская
- =Лицензионно-аккредитационная

}

Формы организации патологоанатомической службы в России:

{

=Патологоанатомические отделения ЛПУ

=Патоморфологические отделы диагностических центров

=Патоморфологические отделы научно-исследовательских учреждений

=Кафедры патологической анатомии вузов

=Патологоанатомические бюро

=Региональные институты патологии

}

Патологоанатомическое вскрытие производится врачом-патологоанатомом в целях получения данных о:

{

=Причине смерти

=Давности наступления смерти

=Диагнозе заболевания

=Внешних причинах смерти

=Давности наступления смерти и внешних причинах смерти

}

Обязательному патологоанатомическому вскрытию подлежат случаи смерти, связанные с проведением мероприятий:

{

=Диагностических

=Анестезиологических

=Реабилитационных

=Лечебных

=Профилактических

}

Основания для выдачи тела умершего без патологоанатомического вскрытия:

{

=Письменное заявление супруга или близкого родственника

=Письменное заявление лечащего врача

=Волеизъявление умершего, сделанное при жизни

=Религиозный мотив

=Любой мотив

}

Без согласия пациента или его законного представителя сведения, составляющие врачебную тайну, передаются должностным лицам в следующих ситуациях:

{

- =В целях обследования и лечения недееспособного гражданина
- =При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых поражений и отравлений
- =В случаях оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет
- =Для публикации в научной литературе, использования в учебном процессе
- =По запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда

}

Патологоанатомическое вскрытие обязательно производится при:

{

- =Рождении мертвого ребенка
- =Подозрению на передозировку или непереносимость фармпрепаратов
- =Подозрению на насильственную смерть
- =Невозможности установления заключительного клинического диагноза и (или) непосредственной причины смерти
- =Смерти в стационаре в срок до 3 койко-дней

}

Для проведения патологоанатомического вскрытия медицинская документация умершего обязательно должна включать (в случае проведения):

{

- =Результаты проведенных исследований
- =Оригиналы проведенных исследований
- =Карты анестезиологических и реанимационных пособий
- =Этапные эпикризы
- =Протоколы операций
- =Посмертный эпикриз
- =Заключительный клинический диагноз
- =Дневники наблюдения

}

Разделение аутопсий по категориям сложности осуществляется исходя из:

{

- =Длительности пребывания в стационаре
- =Необходимости проведения дополнительных методов исследования
- =Степени опасности заражения прозектора инфекционными заболеваниями

=Массы тела умершего

=Степени сложности трактовки характера патологического процесса

}

Архив медицинской организации, производящей патологоанатомические вскрытия включает:

{

=Биологические материалы

=Цитологические препараты

=Гистологические препараты

=Протоколы патологоанатомических вскрытий

=Механические материалы

}

Самостоятельные («независимые») учреждения патологоанатомической службы:

{

=Патологоанатомические отделения (в том числе централизованные) лечебно-профилактических учреждений

=Патологоанатомические отделы (отделения, лаборатории) диагностических центров

=Патологоанатомические отделы (отделения, лаборатории, группы в отделах) научно-исследовательских институтов

=Республиканские, краевые, городские, муниципальные патологоанатомические бюро

=Региональные институты патологии

}

Основные задачи патологоанатомической службы на современном этапе:

{

=Диагностика заболеваний и патологических процессов на основе морфологических исследований биопсийных, операционных материалов, последов

=Диагностика заболеваний и патологических процессов на материалах патологоанатомических вскрытий умерших с установлением причин и механизмов смерти

=Экспертиза качества диагностики и лечения на основе клинико-морфологических сопоставлений

- =Обеспечение информацией органов управления здравоохранения о структуре заболеваемости и причинах смерти населения по материалам патологоанатомических исследований
 - =Предоставление материалов патологоанатомических исследований для обучения врачей и средних медицинских работников
 - =Последипломная подготовка (специализация) и усовершенствование врачей-патологоанатомов и лаборантов-гистологов
- }

Одна ставка врача-патологоанатома выделяется для выполнения следующих объемов работы в течение года:

- {
- =Вскрытие 200 трупов взрослых
 - =Вскрытие 100 трупов взрослых
 - =Вскрытие 160 трупов плодов, мертворожденных, новорожденных, детей
 - =Вскрытие 80 трупов плодов, мертворожденных, новорожденных, детей
 - =Исследование 4000 объектов (кусочков тканей, органов) биопсийного, операционного материалов, последов
 - =Исследование 2000 объектов (кусочков тканей, органов) биопсийного, операционного материалов, после родов
- }

Функциональные обязанности врача-патологоанатома:

- {
- =Патологоанатомические вскрытия трупов взрослых и детей с оформлением установленной документации
 - =Проведение первичной судебно-медицинской экспертизы трупов с оформлением акта экспертизы
 - =Оформление «Медицинских свидетельств о смерти/перинатальной смерти»
 - =Морфологическое исследование биоптатов, операционного материала, последов по существующим стандартам и с учетом современных методических рекомендаций
 - =Анализ качества клинической диагностики и лечения на основе клинко-патологоанатомических сопоставлений
 - =Использование в работе принципов врачебной этики и деонтологии
- }

Отмена патологоанатомического вскрытия трупов взрослых, умерших в стационаре, в машине скорой помощи, вне стационара (дома) не допускается:

{
=В случаях смерти беременных, рожениц, родильниц, включая последний день послеродового периода
=При наступлении смерти от насильственных причин или подозрении на них
=При неустановленности личности умершего
=В случаях смерти от искусственного аборта, проведенного вне лечебного учреждения
=В случаях смерти во время или после хирургической операции, а также в наблюдениях, связанных с проведением профилактических, диагностических, реанимационных, лечебных мероприятий
=В случаях смерти от онкологических заболеваний при отсутствии гистологической верификации опухоли
}

Разрешение на выдачу без вскрытия тела умершего в стационаре может дать:

{
=Главный врач лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ)
=Заместитель главного врача ЛПУ по лечебной работе
=Дежурный врач больницы при отсутствии заместителя главного врача по лечебной работе
=Заведующий патологоанатомическим отделением ЛПУ
=Начальник областного (городского) патологоанатомического бюро
}

Обязательному патологоанатомическому вскрытию подлежат:

{
=Новорожденные, умершие в стационаре, и мертворожденные с массой тела 500 г и более, длиной тела 25 см и более (при сроке 22 нед беременности и более)
=Абортусы и мертворожденные с массой тела менее 500 г (при сроке беременности до 22 нед)
=Трупы детей, умерших в лечебных учреждениях, в возрасте от 7 сут до 14 лет включительно
=Умершие дети вне стационара от инфекционного заболевания или подозрении на него
=Умершие дети при синдроме внезапной смерти
=Умершие дети от новообразования при отсутствии гистологической верификации опухоли
}

На выбор способа и порядка проведения патологоанатомического вскрытия трупа влияют требования:

{

=Эффективной и безопасной работы сотрудников патологоанатомического отделения

=Исключение загрязнения окружающей среды

=Полное исследование органов и систем умершего

=Просьбы родственников умершего

=Исключение действий, ведущих к обезображиванию трупа

}

Современные критерии оценки деятельности стационара по результатам аутопсий:

{

=дифференцированный показатель частоты ошибок прижизненной диагностики основного заболевания: суммарный процент расхождений диагнозов, их распределение по причинам и категориям

=частота (в процентах) ошибок в выявлении летальноопасных осложнений основного заболевания с учетом их причины и адекватности лечения

=частота выявления при патологоанатомических исследованиях ятрогенных заболеваний, своевременность их клинического диагностирования, адекватность лечения

=процент вскрытий трупов умерших в стационаре

=частота (в процентах) отмены руководством ЛПУ учреждения аутопсий с нарушением положений приказа Минздрава РФ «О проведении патологоанатомических вскрытий»

=количество заседаний КИЛИ, ЛКК, клинико-анатомических конференций и проанализированных случаев летального исхода

}

Вскрытие черепа мертворожденного и умершего новорожденного производят:

{

=по Фишеру

=по Далю

= "корзиночкой"

=по Шору

=по Абрикосову

}

Аутопсия – это:

{

=Морфологическое исследование последа - органа, связывающего плод с организмом матери

=Морфологическое исследование органокомплексов, органов (или их части), тканей, полученные при различных вариантах оперативного вмешательства

=Патологоанатомическое вскрытие, секция

=Комплексная врачебная лечебно-медицинская услуга

=Морфологическое исследование прижизненно иссеченных или изъятых другим способом тканей и частей органов

}

Основные правила проведения патологоанатомических вскрытий трупов в отечественном здравоохранении регламентируются:

{

=Приказом Министерства здравоохранения РФ № 354н от 6 июня 2013 г. «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий»

=Статьей 67 «Проведение патологоанатомических вскрытий» Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

=Приказом Министерства здравоохранения РФ № 352н от 15 апреля 2021 г. «Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи»

=Статьей 8 Федерального закона от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

=Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1687н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»

}

В каких случаях проведение патологоанатомического вскрытия (аутопсии) обязательно:

{

=Мертворождение

=Смерть от осложнения сахарного диабета

=Смерть от пневмонии у пациента с ВИЧ-инфекцией

=Материнская смерть

=Смерть от осложнения острого инфаркта миокарда

}

В каких случаях проведение патологоанатомического вскрытия (аутопсии) обязательно:

{

=От смертельного осложнения соматического заболевания, развившегося вне лечебного учреждения

=От онкологического заболевания при наличии гистологической верификации опухоли

=Оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток

=Подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов

=Невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти

}

Диагностическая и экспертная функция патологоанатомической службы состоит в:

{

=Прижизненной диагностике заболеваний и патологических процессов с помощью морфологических исследований биоптатов, операционного материала и последствий

=Анализе структуры заболеваемости и причин смерти населения по материалам патологоанатомических исследований

=Учете результатов окончательной (посмертной) диагностики заболеваний и патологических процессов по материалам патологоанатомических вскрытий с установлением причин и механизмов смерти

=Динамическом контроле за эффективностью лечения путем производства повторных прижизненных морфологических исследований

=Экспертизе качества диагностики и лечения на основе клинико-морфологических сопоставлений

}

Историю болезни, направляемую на вскрытие, визирует:

{

=лечащий врач

=главный врач

=дежурный администратор

=патологоанатом

=мед сестра

}

В чьи обязанности не входит решение о выдаче тела умершего пациента родственникам без патологоанатомического вскрытия:

{

=В обязанности дежурного врача

=В обязанности главного врача

=В обязанности лечащего врача

=В обязанности заведующего клиническим отделением

=В обязанности заведующего патологоанатомическим отделением

}

*на месте нужно
отдать ваучер
отвечать*

В каких случаях патологоанатомическое вскрытие (аутопсию) нужно проводить:

{

=Смерть пациента в приемном покое с кровоизлиянием в левое полушарие головного мозга от отека головного мозга

=Смерть пациента с сахарным диабетом от ковидной пневмонии

=Смерть новорожденного

=Смерть пациента с низкодифференцированной аденокарциномой правого легкого от кахексии

=Смерть роженицы

}

На выбор способа и порядка проведения патологоанатомического вскрытия трупа влияют требования:

{

=Эффективной и безопасной работы сотрудников патологоанатомического отделения

=Исключение загрязнения окружающей среды

=Полное исследование органов и систем умершего

=Просьбы родственников умершего

=Исключение действий, ведущих к обезображиванию трупа

}

«Протокол патологоанатомического вскрытия» не является приложением к действующим приказам:

{

=Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 502н от 5 мая 2012 г. «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»

=Приказу Министерства здравоохранения РФ № 352н от 15 апреля 2021 г. «Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи»

=Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 782н от 26 декабря 2008 г. «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти»

=Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1687н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»

=Приказу Министерства здравоохранения РФ № 354н от 6 июня 2013 г. «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий»

}

//РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ О ДИАГНОЗЕ

При регистрации в загсе «Медицинского свидетельства о смерти» наряду с ними представляются «Медицинские свидетельства о рождении» (форма №103/у-98) в случае:

{

=Аntenатальной смерти плода массой тела 1000 г и более и длиной тела 25 см и более

=Смерти на 1-й неделе жизни ребенка с массой тела при рождении 1000 г и более и длиной тела 25 см и более

=Смерти ребенка в возрасте 7 сут и более с массой тела при рождении 500 – 999 г и длиной тела менее 25 см

=Смерти ребенка на 8 – 30-е сутки постнатальной жизни вне зависимости от морфологических показателей при рождении

=Интранатальной смерти плода массой тела 1000 г и более и длиной тела 25 см и более

}

Медицинское свидетельство о смерти оформляется в следующих случаях, кроме:

{

=После судебно-медицинского вскрытия

=После патологоанатомического вскрытия

=На основании предшествовавшего наблюдения за пациентом

=На основании постановления прокуратуры

=На основании осмотра трупа и записи в медицинской документации

}

К медицинскому документу, удостоверяющему случай рождения не относятся:

{

=Медицинское свидетельство о рождении

=Свидетельство о рождении

=Справка о рождении

=История родов

=Карта новорожденного

}

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти заполняется на мертворожденных при наличии хотя бы одного признака:

{

=Масса тела более 1000 г

=Срок гестации более 28 недель

=Масса тела более 500 г

=Длина тела больше 35 см

=Длина тела больше 30 см

}

Медицинские документы, удостоверяющие случаи смерти живорожденных до 168 часов:

{

=Медицинское свидетельство о рождении

=Свидетельство о смерти

=Медицинское свидетельство о смерти

=Медицинское свидетельство о перинатальной смерти

=Медицинская карта

}

В случае смерти новорожденного спустя 7 суток после рождения оформляется:

{

=Медицинское свидетельство о перинатальной смерти

=Медицинское свидетельство о рождении

=Медицинское свидетельство о смерти

=Медицинская карта

=Медицинская справка
}

Медицинское свидетельство о смерти заполняется:

{
=Лечащим врачом
=Патологоанатомом
=Заведующим клиническим отделением
=Председателем врачебной комиссии (ВК)
=Судебно-медицинским экспертом
}

Установление причины смерти при оформлении медицинского свидетельства о смерти возможно на основании:

{
=Осмotra трупа
=Записей в медицинской документации
=Опроса родственников
=Предшествующего наблюдения за больным
=Вскрытия
}

В протоколе патологоанатомического вскрытия (форма n 013/y) предусмотрено заполнение диагнозов:

{
=Заключительного клинического
=Патологоанатомического предварительного
=При поступлении
=Патологоанатомического
=Направившего учреждения
}

В каких случаях оформляется медицинское свидетельство о перинатальной смерти:

{
=Смерть на вторые сутки новорожденного с массой тела 1950 г =Смерть через 12 часов новорожденного с массой тела 700 г
=Рождение мертвого плода при сроке беременности 24 недели
=Смерть ребенка в возрасте 18 месяцев

=Смерть на восьмые сутки новорожденного с массой тела при рождении 800 г
}

Медицинское свидетельство о смерти оформляется следующими медицинскими работниками:

{
=Медрегистратором
=Врачом - судебно-медицинским экспертом
=Врачом (фельдшером), установившим смерть
=Врачом - патологоанатомом
=Лечащим врачом
}

Медицинское свидетельство о смерти выдается:

{
=Членам семьи
=Родственникам умершего
=Лечащему врачу
=Ответственным за проведение похорон
=Знакомым
}

Виды диагноза по способу построения и обоснования:

{
=Прямой
=Косвенный
=Дифференциальный
=Недифференциальный
=Непрямой
}

Виды диагноза в медицине:

{
=Клинический
=Патологоанатомический
=Судебно-медицинский
=Посмертный
=Эпидемиологический
}

Принципы формирования диагноза в отечественной медицине:

{

=Нозологический

=Соответствие МКБ-10

=Симптоматический

=Патогенетический

=Несоответствие МКБ-10

}

Нозологическая единица в составе основного заболевания:

{

=Имеет наиболее выраженные проявления

=Не принимает участие в танатогенезе (механизме смерти)

=Угрожает здоровью и жизни больного

=В танатогенезе является первоначальной причиной смерти

=Не угрожает жизни и здоровью больного

}

Виды патогенетической и танатологической связи нозологических единиц при бикаузальном генезе заболевания:

{

=Конкурирующие заболевания

=Комбинированные заболевания

=Сочетанные заболевания

=Фоновое заболевание

=Семейство болезней

=Ассоциация болезней

}

Виды патогенетической и танатологической связи нозологических единиц при мультикаузальном генезе заболевания:

{

=Конкурирующие заболевания

=Комбинированные заболевания

=Сочетанные заболевания

=Фоновое заболевание

=Семейство болезней

=Ассоциация болезней

}

Бикаузальным может быть диагноз:

{

=Заключительный клинический

=Патологоанатомический

=Судебно-медицинский

=Эпидемиологический

=Эпидемиологический и клинический

}

В случае летального исхода болезни непосредственной причиной смерти может быть:

{

=Основное заболевание

=Осложнение

=Сопутствующее заболевание

=Остановка сердечной деятельности

=Остановка сердца и сопутствующее заболевание

}

Функции диагноза:

{

=Статистическая

=Тактическая

=Преемственности

=Дидактическая

=Диалектическая

}

Статическими являются диагнозы:

{

=Патологоанатомический

=Заключительный клинический

=Клинический

=Судебно-медицинский

=Клинико-сопутствующий

}

Предварительными являются диагнозы:

{

=При поступлении

=Заключительный клинический

=Направившего учреждения

=Патологоанатомический

=Судебно-медицинский

}

Ятрогении первой категории:

{

=Имеют патогенетическую связь с основным заболеванием

=Не имеют патогенетическую связь с основным заболеванием

=Участвуют в танатогенезе

=Не участвуют в танатогенезе

=Участвуют в танатогенезе и имеют патогенетическую связь

}

Ятрогении второй категории:

{

=имеют патогенетическую связь с основным заболеванием

=не имеют патогенетическую связь с основным заболеванием

=участвуют в танатогенезе

=не участвуют в танатогенезе

=имеют патогенетическую связь и не участвуют в танатогенезе

}

Ятрогении третьей категории:

{

=Связаны с правильными действиями медицинского персонала

=Связаны с неправильными действиями медицинского персонала

=Участвуют в танатогенезе

=Не участвуют в танатогенезе

=Связаны с правильными действиями медицинского персонала и не участвуют в танатогенезе

}

Ятрогенное заболевание 2 группы является:

{

- =Конкурирующим заболеванием
- =Сочетанным заболеванием
- =Фоновым заболеванием
- =Основным заболеванием
- =Сопутствующим заболеванием

}

Ятрогении второй категории:

{

- =связаны с правильными действиями медицинского персонала
- =связаны с неправильными действиями медицинского персонала
- =участвуют в танатогенезе
- =не участвуют в танатогенезе
- =связаны с неправильными действиями медицинского персонала и не участвуют в танатогенезе

}

В структуре клинического диагноза место ятрогении зависит от:

{

- =степени вызванных ею структурно-функциональных нарушений
- =ее влияния на прогноз для жизни
- =необходимостью ее лечения
- =ее ролью в танатогенезе
- =локализации ее проявлений

}

Понятие «диагноз в медицине» содержит заключение о:

{

- =Состоянии здоровья обследуемого
- =Имеющемся у обследуемого заболевании (травме) или о причине смерти
- =Виновности врача, допустившего дефект оказания медицинской помощи, приведшего к смерти
- =Эпидемическом очаге инфекционной болезни
- =Виновности врача и состояния здоровья обследуемого

}

Принципы формулирования и оформления патологоанатомического диагноза:

{

- =Нозологический в соответствии с МКБ-10

- =Индивидуальность
- =Своевременность и динамизм
- =Патогенетический
- =Структурность с унифицированными рубриками
- =Фактическая и логическая обоснованность

В международной классификации и номенклатуре болезни, патологические состояния выделены в нозологические единицы (формы) на основе совокупности следующих признаков:

- {
- =Установленные этиология и патогенез
- =Характерная клинико-морфологическая картина
- =Социально-экономическая значимость
- =Тяжесть процесса
- =Участие в танатогенезе
- }

Осложнение основного заболевания - это патологический процесс:

- {
- =Патогенетически связанный с основным заболеванием, но не входящий в типичную клинико-морфологическую характеристику этого заболевания
- =Утяжеляющий течение основного заболевания, патогенетически и этиологически связанный с ним
- =Утяжеляющий течение основного заболевания, патогенетически тесно с ним связанный, но иной этиологии
- =Приведший к смерти, находящийся в тесной причинно-следственной связи с основным заболеванием и не оцениваемый в МКБ-10 в качестве первоначальной причины смерти
- =Утяжеливший течение основного заболевания, имеющий иную этиологию и патогенез
- }

15 Характеристика понятия «конкурирующее заболевание»:

- {
- =Вариант полипатии
- =Вариант комбинированного основного заболевания
- =Каждое из этих заболеваний могло привести к смерти
- =Одновременно развившиеся у пациента 3 тяжелые болезни

=Мультикаузальный генез
}

В качестве «непосредственной причины смерти» можно выставить в диагнозе:

{
=Сердечную недостаточность
=Механизм смерти
=Травму
=Заболевание
=Главное осложнение основного заболевания (травмы)
=Фибрилляцию желудочков сердца
}

Возможное место ятрогении в заключительном клиническом и патологоанатомическом диагнозах:

{
=Основное заболевание
=Сопутствующее заболевание
=Осложнение основного заболевания
=Конкурирующее заболевание
=Сочетанное заболевание
=Заболевание в составе полипатии
}

Установить причину смерти и оформить «Медицинское свидетельство о смерти» может:

{
=Врач, лечивший больного
=Врач, только установивший смерть
=Фельдшер
=Медицинская сестра
=Патологоанатом
=Судебно-медицинский эксперт
}

При оформлении «Медицинского свидетельства о смерти» для определения причин смерти может использоваться:

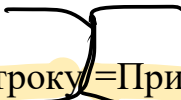
{
=Вскрытие трупа

=Осмотр трупа
=Записи в медицинской документации
=Предшествующее наблюдение за больным
=Информация родственников и близких
}

Основное заболевание - это нозологическая единица, которая в данный момент и в данных условиях в наибольшей степени:

{
=Угрожает жизни больного
=Угрожает здоровью больного
=Угрожает трудоспособности больного
=Требуется проведения первоначальных лечебно-профилактических мероприятий
=Само или через осложнения явилось причиной смерти
}

Правильное заполнение врачебного свидетельства о смерти требует выполнения следующих условий:

{
=Непосредственная причина смерти записывается в верхнюю строку,  =При совпадении первоначальной и непосредственной причин - также в первую строку
=Первоначальная причина смерти записывается в нижнюю строку, с учетом ранее заполненных строк (в строку б, или в)
=Первоначальная причина смерти - кодируется и используется в качестве причины смерти больного во всех документах
=Основное заболевание - кодируется и используется в качестве причины смерти больного во всех документах
}

Что входит в структуру диагноза при бикаузальном генезе болезни и смерти:

{
=2-я полипатия
=Сопутствующее заболевание
=Сочетанное заболевание
=Фоновое заболевание
=Основное заболевание
}

Аспекты понятия «болезнь»:

{
=Экономический
=Клинический
=Медико-статистический
=Демографический
=Медико-биологический
}

Что такое «болезнь»:

{
=Медицинское заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об имеющемся заболевании или о причине смерти, выраженное в терминах, предусмотренных принятыми классификациями и номенклатурой болезней
=Это состояние, определяющееся совокупностью клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом
=Это совокупность клинических, лабораторных и инструментальных, диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом
=Неустойчивая форма жизнедеятельности организмов вследствие генетического дефекта или воздействия повреждающего фактора внешней среды
=Совокупность патологических, компенсаторных и приспособительных реакций на действие патогена
}

Что входит в структуру диагноза при мультикаузальном генезе болезни и смерти:

{
=Сопутствующее заболевание
=Основное заболевание
=2-я полипатия
=Сочетанное заболевание
=Фоновое заболевание
}

Что входит в структуру диагноза при монокаузальном генезе болезни и смерти:

{
=2-я полипатия
=Сочетанное заболевание

=Фоновое заболевание
=Основное заболевание
=Сопутствующее заболевание
}

Кто имеет право устанавливать диагноз:

{
=Врач
=Фельдшер
=Санитар
=Адвокат
=Медбрат
}

Ятрогенное заболевание 3 группы не является:

{
=Конкурирующим заболеванием
=Сочетанным заболеванием
=Фоновым заболеванием
=Основным заболеванием
=Сопутствующим заболеванием
}

Ятрогенное заболевание 1 группы не является:

{
=Основным заболеванием
=Сопутствующим заболеванием
=Конкурирующим заболеванием
=Фоновым заболеванием
=Сочетанным заболеванием
}

В случаях анафилактического шока и смерти во время наркоза и анестезии при правильных, по показаниям проведенных диагностических, лечебных, реанимационных и реабилитационных мероприятиях ятрогенная патология не регистрируется в рубрике:

{
=осложнения основного заболевания
=основное заболевание

=сопутствующие заболевания
=второе конкурирующее заболевание
=второе сочетанное заболевание
}

В любой рубрике диагноза допустимо использовать следующие корректные термины:

{
=ювенильный ревматоидный артрит
=прогрессирующий атеросклероз аорты
=коронарокардиосклероз
=крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз
=хроническая аневризма сердца
}

Патологоанатомический диагноз не начинают:

{
=С нозологической единицы («ключевого слова», единицы статистического, учета) основного заболевания - первоначальной причины смерти
=С непосредственной причины смерти
=С патологического процесса, запустившего патогенетическую цепь
=С патологического процесса и непосредственной причины смерти
=С патогенетической цепи
}

В патологоанатомическом диагнозе ятрогении III категории не занимают место в рубрике:

{
=основного заболевания
=сопутствующего заболевания
=фонового заболевания
=конкурирующих заболеваний
=осложнения основного заболевания
}

В патологоанатомическом диагнозе ятрогении I категории не занимают место в рубрике:

{
=основного заболевания

- =сопутствующего заболевания
- =фонового заболевания
- =конкурирующих заболеваний
- =осложнения основного заболевания

}

Ятрогения в заключительном клиническом и патологоанатомическом диагнозах может быть в составе:

{

- =Основного заболевания
- =Сопутствующего заболевания
- =Осложнения основного заболевания
- =Конкурирующего заболевания
- =Сочетанного заболевания

}

//РАЗДЕЛ 3. КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Признаками расхождения диагнозов первой категории являются:

{

- =Объективные трудности диагностики
- =Субъективные трудности диагностики
- =Дефект диагностики на предыдущем этапе обращения
- =Летальный исход не связан с ошибкой диагностики
- =Объективно-субъективные трудности диагностики

}

Признаками расхождения диагнозов второй категории являются:

{

- =Объективные трудности диагностики
- =Субъективные трудности диагностики
- =Дефект диагностики на предыдущем этапе обращения
- =Летальный исход не связан с ошибкой диагностики
- =Летальный исход связан с ошибкой диагностики

}

К объективным трудностям диагностики относятся:

{

- =Тяжесть состояния больного

- =Недостаточное обследование больного
- =Кратковременность пребывания в медицинской организации
- =Недоучет (переоценка) заключения консультантов
- =Неправильное построение (оформление диагноза)

К субъективным трудностям диагностики относятся:

- {
- =Тяжесть состояния больного
- =Недостаточное обследование больного
- =Кратковременность пребывания в медицинской организации
- =Недоучет (переоценка) заключения консультантов
- =Неправильное построение (оформление диагноза)
- }

Расхождением диагнозов считается несовпадение основного заболевания по:

- {
- =Нозологическому принципу
- =Степени функциональных расстройств
- =Этиологическому признаку
- =Патогенетическому признаку
- =Локализации
- }



Категорию расхождения диагнозов определяет:

- {
- =Лечащий врач
- =Патологоанатом
- =Заведующий клиническим отделением
- =Главный врач
- =КИЛИ
- }

Дефектами оказания медицинской помощи являются ошибки:

- {
- =Диагностики
- =Лечения
- =Экспертизы трудоспособности
- =Организации медицинской помощи
- }

=Экспертизы и лечения
}

Врачебные ошибки подразделяются на:

{
=Диагностические
=Лечебные
=Методические
=Организационные
=Профилактические
}

Виды врачебных ошибок в зависимости от этапа и характера профессиональных действий врача:

{
=Диагностические
=Связанные с врачебными мероприятиями
=Связанные с неадекватным поведением пациента
=Организационные
=Связанные с проведением профилактических мероприятий
=Связанные с недостаточностью материально-технической базы учреждения
}

К диагностическим ошибкам, выявляемым при сличении заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, относят расхождение диагнозов по:

{
=Основному заболеванию
=Важнейшим осложнениям
=Важнейшим сопутствующим заболеваниям
=Вторичным осложнениям
=Сочетанному заболеванию
}

Диагностическая ошибка оценивается как расхождение диагнозов по основному заболеванию в случае:

{
=Трактовки основного заболевания в клиническом диагнозе в качестве сопутствующего

=Применения синонима для обозначения основного заболевания, не указанного в международной номенклатуре и классификации болезней
=Нераспознавания одного из заболеваний, входящих в состав комбинированного основного заболевания
=Нераспознавания одного из заболеваний из семейства или ассоциации болезней
=Несовпадения по локализации поражений и по этиологии патологического процесса
}

Категория расхождения диагнозов устанавливается при расхождении диагнозов по:

{
=Основному заболеванию
=Опасному осложнению
=Сопутствующему заболеванию
=Нозологической форме в составе комбинированного основного заболевания
=Нозологической форме в составе полипатии
}

С медико-правовых позиций выделяют следующие ДОМП:

{
=Медицинский деликт
=Врачебная ошибка
=Поздняя госпитализация
=Несчастный случай
=Ятрогенные заболевания
}

С клинико-патологоанатомических позиций выделяют следующие ДОМП:

{
=Профилактические
=Реабилитационные
=Диагностические
=Организационные
=Ятрогенные
}

Задачами КИЛИ являются:

{

- =установление причины смерти
- =установление категории расхождения диагнозов
- =контроль качества ведения медицинской документации
- =установление причины диагностических ошибок
- =привлечение к дисциплинарной ответственности

}

Обязательный состав КИЛИ:

{

- =Председатель
- =Секретарь
- =Рецензент
- =Оппонент
- =Члены кили

}

Предметом анализа летальных исходов на ЛКК являются:

{

- =Ятрогенные осложнения
- =Диагностические ошибки при ургентной патологии
- =Расхождения диагнозов III категории
- =Расхождения диагнозов I-II категории
- =Случаи, вынесенные кили на ЛКК

}

Этапы клинико-анатомической конференции:

{

- =клиническая часть
- =лабораторная часть
- =выступление патологоанатома
- =выступление заведующего клиническим отделением
- =выступление рецензента
- =заключение председателя

}

В клинико-патологоанатомическом эпикризе отражаются:

{

- =Обоснование диагноза основного заболевания

- =Углубленная интранозологическая характеристика основного заболевания, его особенности, включая патоморфоз
- =Непосредственная причина смерти, ее механизм или вид
- =Обсуждение осложнений лечебных и диагностических мероприятий, их роль в танатогенезе
- =Причина и категория расхождения диагнозов, других дефектов диагностики и лечения
- =Суждение о виновности медицинского персонала в неблагоприятном исходе заболевания
- }

Этапы коллегиального анализа летальных исходов в лечебно-профилактическом учреждении:

- {
- =Проведение клинико-морфологических сопоставлений, анализа качества оказания медицинской помощи с участием лечащего врача у секционного стола
- =Контроль заведующего патологоанатомическим отделением за соблюдением стандартов патологоанатомической диагностики и экспертизы врачами отделения
- =Обсуждение всех случаев летального исхода на заседаниях комиссии по изучению летальных исходов ЛПУ
- =Углубленный анализ сложных и спорных случаев ЛКК больницы
- =Углубленный разбор наиболее сложных и спорных случаев на клинико-анатомических конференциях
- }

При подготовке и проведении очередной клинико-анатомической конференции главный врач ЛПУ исходит из следующих методических рекомендаций:

- {
- =Подготовка и организация конференций возлагаются на заместителя главного врача по медицинской части и заведующего патологоанатомическим отделением, они же назначаются председателями конференции
- =Сопредседатели конференции определяют повестку конференции и доводят ее в письменном виде до сведения врачей учреждения не позднее чем за 7 дней до начала конференции
- =Основными докладчиками на конференции являются лечащий врач, патологоанатом и рецензент, назначенный из числа наиболее квалифицированных врачей-клиницистов
- }

=Каждая конференция должна сопровождаться обзором современной литературы по анализируемой проблеме и проходить в атмосфере критического подхода к разбираемому материалу

=По итогам проведенного обсуждения в обобщающем выступлении сопредседателей вносятся предложения, направленные на повышение качества лечебно-диагностического процесса и совершенствование проведения последующих конференций

=Клинико-анатомическая конференция проводится в нерабочее время, участие в ее работе не относится к функциональным обязанностям врачей данного ЛПУ
}

В числе причин расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов основных заболеваний выделяют:

{
=Недостаточность обследования больного и объективные трудности исследования
=Недоучет клинических и лабораторных данных
=Переоценку клинических и лабораторных данных
=Недоучет и переоценку рентгенологических и других функциональных данных
=Неправильное оформление и построение диагнозов
}

Цель клинико-патологоанатомической экспертизы качества медицинской помощи:

{
=Комплексный характер проводимого исследования, относящийся, в настоящее время, к врачебным лечебно-диагностическим медицинским услугам
=Морфологическое исследование прижизненно иссеченных или изъятых другим способом тканей и частей органов для целей диагностики и /или оценки эффективности примененного лечения
=Выявление нарушений (дефектов) при оказании медицинской помощи
=Оценка своевременности ее оказания
=Правильность выбора методов профилактики, лечения и реабилитации
}

Категории оценок при сличении клинического и патологоанатомического диагнозов:

{
=Запоздалая клиническая диагностика основного заболевания

- =Расхождение диагнозов по важнейшему смертельному осложнению
- =Запоздавшая клиническая диагностика тяжелого осложнения
- =Расхождение диагнозов по основному заболеванию
- =Расхождение диагнозов по сопутствующему заболеванию

}

Укажите субъективные причины расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов:

{

- =Редкость и недостаточная изученность заболевания
- =Трудность или невозможность обследования больного из-за тяжести состояния
- =Недостаточное клиническое обследование
- =Неправильная интерпретация клинических данных
- =Недооценка или переоценка результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических, цитологических и других методов обследования

}

К объективным причинам расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов не относятся:

{

- =Кратковременность пребывания больного в стационаре
- =Недостаточное клиническое обследование
- =Недооценка или переоценка результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических, цитологических и других методов обследования
- =Трудность или невозможность обследования больного из-за тяжести состояния
- =Атипичность развития болезни и течения процесса

}

К объективным причинам расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов относятся:

{

- =Редкость и недостаточная изученность заболевания
- =Неправильная интерпретация клинических данных
- =Неправильное оформление и построение клинического диагноза
- =Недостаточность материально-технической базы учреждения здравоохранения
- =Переоценка заключения консультантов

}

Перечислите объективные причины расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов:

{

=Трудность или невозможность обследования больного из-за тяжести состояния

=Недостаточное клиническое обследование

=Переоценка заключения консультантов

=Недостаточность материально-технической базы учреждения здравоохранения

=Атипичность развития болезни и течения процесса

}

Субъективные причины расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов:

{

=Недостаточное клиническое обследование

=Переоценка заключения консультантов

=Недостаточность материально-технической базы учреждения здравоохранения

=Кратковременность пребывания больного в стационаре

=Атипичность развития болезни и течения процесса

}

К субъективным причинам расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов относятся следующие:

{

=Недооценка или переоценка результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических, цитологических и других методов обследования

=Недостаточное клиническое обследование

=Неправильное оформление и построение клинического диагноза

=Недостаточность материально-технической базы учреждения здравоохранения

=Атипичность развития болезни и течения процесса

}

Этапы проведения клинко-анатомического анализа:

{

=На клинко-патологоанатомической конференции

=На студенческой научной конференции

=На подкомиссии по изучению летальных исходов

=У секционного стола

=На лечебно-контрольной комиссии

}

Перечислите субъективные причины расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов:

{

=Редкость и недостаточная изученность заболевания

=Недостаточность материально-технической базы учреждения здравоохранения

=Трудность или невозможность обследования больного из-за тяжести состояния

=Неправильная интерпретация клинических данных

=Переоценка заключения консультантов

}

К субъективным причинам расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов не относятся:

{

=Недостаточность материально-технической базы учреждения здравоохранения

=Трудность или невозможность обследования больного из-за тяжести состояния

=Неправильная интерпретация клинических данных

=Редкость и недостаточная изученность заболевания

=Переоценка заключения консультантов

}

К расхождению клинического и патологоанатомического диагнозов по основному заболеванию относятся несовпадение диагнозов по:

{

=Времени клинической диагностики основного заболевания

=Этиологии патологического процесса

=Времени клинической диагностики тяжелого осложнения

=Локализации поражения (в том числе при отсутствии в заключительном клиническом диагнозе указаний на топiku процесса)

=Нозологическому принципу

}

К расхождению клинического и патологоанатомического диагнозов по основному заболеванию относятся несовпадение диагнозов:

{

=Случаи ошибочной трактовки основного заболевания в качестве сопутствующего

=Нераспознавание одного из заболеваний, входящих в состав комбинированного основного заболевания

- =Запоздалая клиническая диагностика основного заболевания
- =Запоздалая клиническая диагностика тяжелого осложнения
- =Нераспознавание одной из нозологических единиц, входящих в состав полипатии

Понятие «врачебная ошибка» включает все перечисленные ниже положения:

- {
- =Некачественное оказание медицинской помощи (дефекты диагностики, лечения и т.д.), приведшее к ухудшению состояния здоровья пациента, вне зависимости от причин дефектов профессиональной деятельности
- =Некачественное оказание медицинской помощи, которое могло привести к ухудшению состояния здоровья больного, вне зависимости от причин дефектов профессиональной деятельности
- =Дефекты оказания медицинской помощи, возникшие по объективным и субъективным причинам, обусловившие наступление смертельного исхода
- =Дефекты оказания медицинской помощи вне зависимости от их причины, которые могли повлиять на наступление смертельного исхода
- =Некачественное оказание медицинской помощи, ведущие к ухудшению состояния здоровья пациента, при исключении в действиях медицинских работников элементов противоправности и виновности

К объективным причинам врачебных ошибок не относятся:

- {
- =Кратковременность пребывания больного в стационаре
- =Дефекты лабораторных, аппаратных, инструментальных и др. исследований
- =Сложность и недостаточная изученность заболевания
- =Недооценка или переоценка роли консультантов
- =Неправильная формулировка заключительного диагноза

Признаками расхождения диагнозов третьей категории не являются:

- {
- =Объективные трудности диагностики
- =Субъективные трудности диагностики
- =Дефект диагностики на предыдущем этапе обращения
- =Летальный исход не связан с ошибкой диагностики
- =Летальный исход связан с ошибкой диагностики

//РАЗДЕЛ 4. БИОПСИЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

К объектам прижизненной морфологической диагностики относятся:

- {
- =Биопсийный материал
- =Операционный материал
- =Послед
- =Экспериментальный материал
- =Биологические жидкости
- }

Исследование последа включает:

- {
- =Осмотр и макроскопическое описание
- =Макроморфометрию
- =Взвешивание
- =Забор материала на бактериологическое исследование
- =Забор материала на гистологическое исследование
- }

Технологическая цепочка исследования объектов прижизненной морфологической диагностики включает:

- {
- =Прием и регистрацию материала
- =Макроскопическое описание и вырезку
- =Забор материала на бактериологическое исследование
- =Гистологическую обработку объектов
- =Морфологическую диагностику
- =Выдачу заключений и архивирование
- }

Для полноценной морфологической диагностики заболеваний лечащий врач должен обеспечить:

- {
- =Маркировку объектов исследования
- =Фиксацию объектов исследования
- =Указание точного количества объектов

- =Заполнение в двух экземплярах направления на гистологическое исследование (форма № 14/у)
- =Визу главного врача (или его заместителя по лечебной части) на исследование
- =Своевременную доставку объектов в патологоанатомическое отделение (бюро)

В направлении на гистологическое исследование диагностического соскоба эндометрия врач-гинеколог указывает:

- {
- =Развернутый клинический диагноз
- =Результаты и координаты предыдущих гистологических исследований
- =Дату начала и окончания последней менструации или кровотечения
- =Характер нарушения менструальной функции
- =Национальность женщины
- =Число и исходы беременностей
- =Результаты осмотра терапевта
- }

Исследование последа позволяет определить риск развития:

- {
- =Риск по послеродовому эндометриту
- =Риск по внутриутробной инфекции
- =Риск по постгипоксической энцефалопатии
- =Риск по преждевременным родам
- =Риск по гемолитической болезни
- }

Виды прижизненной морфологической диагностики:

- {
- =Биопсия
- =Исследование операционного материала
- =Аутопсия
- =Исследование последа
- =Исследование мазка крови
- }

Правильность прижизненной морфологической диагностики зависит от:

- {
- =Соблюдений правил утилизации материала

- =Соблюдений правил фиксации материала
- =Соблюдений правил консервации материала
- =Соблюдений правил забора материала
- =Соблюдений правил маркировки материала

}

Цель исследования биопсийного материала:

{

- =Контроль качества хирургической операции
- =Оценка эффективности примененного лечения
- =Установление диагноза
- =Контроль объема оперативного вмешательства
- =Уточнение до- и интраоперационного клинического диагноза

}

Выберите пример описательного ответа патологоанатома:

{

- =В объеме исследуемого биоптата пласт зрелого многослойного плоского эпителия без подлежащей основы
- =Хронический поверхностный минимально выраженный неактивный антрум гастрит без НР- обсемененности
- =Железистый полип цервикального канала
- =В срезах лимфатического узла имеются эпителиоидно-клеточные гранулемы без признаков некроза, характерные для туберкулеза и саркоидоза
- =В представленном материале скопления эритроцитов, слизи, гранулоцитов, обрывки железистого эпителия

}

Исследование последа позволяет установить:

{

- =Недоношенность
- =Соответствие плаценты сроку гестации
- =Морфофункциональную незрелость плода
- =Наличие инфекции плода и путь ее проникновения
- =Функциональную недостаточность последа

}

Криостат используют для:

{

- =Заливки
- =Окраски
- =Проводки
- =Резки
- =Замораживания

}

Цель исследования операционного материала:

{

- =Диагностика патологических процессов, связанных с болезнями плода или матери
- =Уточнение до- и интраоперационного клинического диагноза
- =Контроль объема оперативного вмешательства
- =Контроль качества хирургической операции
- =Установление диагноза

}

Виды патогистологического заключения:

{

- =Ориентировочный патогистологический диагноз
- =Окончательное патогистологическое заключение
- =Предварительный патологоанатомический диагноз
- =Заключительный клинический диагноз
- =Описательный ответ патологоанатома

}

Цель исследования последа:

{

- =Диагностика патологических процессов, связанных с болезнями матери
- =Оценка эффективности примененного лечения
- =Установление диагноза
- =Уточнение до- и интраоперационного клинического диагноза
- =Диагностика патологических процессов, связанных с болезнями плода

}

Выявление наличия рецепторов к эстрогену в опухоли молочной железы – это:

{

- =Бактериоскопический метод
- =Молекулярно-биологический метод

=Иммуногистохимический метод

=Микроскопический метод

=Гистохимический метод

}

Установите нормативы сроков выполнения для срочной и плановой биопсии:

{

=До 20-25 мин

=До 1 часа

=В пределах 5 суток

=До 10 суток

=До 20-30 суток

}

Методы исследования, используемые при срочной (интраоперационной) биопсии:

{

=электронная микроскопия

=иммуногистохимия

=гистологический

=цитологический

=ПЦР

}

К методам молекулярной патологии не относятся:

{

=гистохимическое исследование

=полимеразная цепная реакция

=проточная цитофотометрия

=метод клеточных и тканевых культур

=гистофотометрия

}

Методы, которые не используются при необходимости срочного исследования эндоскопических биопсий, рыхлых, ослизненных, жировой и костной тканей:

{

=электронная микроскопия

=иммуногистохимия

=гистологический

=цитологический

=ПЦР

}

К ориентировочному патогистологическому диагнозу не относятся:

{

=В представленном материале скопления эритроцитов, слизи, гранулоцитов, обрывки железистого эпителия

=В срезах лимфатического узла имеются эпителиоидно-клеточные гранулемы без признаков некроза, характерные для туберкулеза и саркоидоза

=Субмукозная миома тела матки

=В представленном материале крайне скудный фрагмент покровного желудочного эпителия

=Тубулярная аденома легкой степени клеточной дисплазии в гиперпластическом полипе толстой кишки

}

Для правильной фиксации фрагментов органов и тканей не используют:

{

=10% раствор формалина

=Изопропиловый спирт

=1% раствор перекиси водорода

=40% раствор формалина

=70% этиловый спирт

}

К окончательному патогистологическому заключению не относятся:

{

=В срезах лимфатического узла имеются эпителиоидно-клеточные гранулемы без признаков некроза, характерные для туберкулеза и саркоидоза

=В объеме исследуемого биоптата пласт зрелого многослойного плоского эпителия без подлежащей основы

=Тубулярная аденома легкой степени клеточной дисплазии в гиперпластическом полипе толстой кишки

=В представленном материале скопления эритроцитов, слизи, гранулоцитов, обрывки железистого эпителия

=Железистый полип цервикального канала

}

В направлении на гистологическое исследование диагностического соскоба эндометрия врач-гинеколог указывает:

{

=Развернутый клинический диагноз

=Результаты и координаты предыдущих гистологических исследований

=Дату начала и окончания последней менструации или кровотечения

=Характер нарушения менструальной функции

=Национальность женщины

}

Для полноценной морфологической диагностики заболеваний лечащий врач обязан обеспечивать:

{

=Маркировку объектов исследования

=Фиксацию объектов исследования

=Указание точного количества объектов

=Заполнение в двух экземплярах направления на гистологическое исследование (форма № 14/у)

=Визу главного врача (или его заместителя по лечебной части) на исследование

}

В случаях диагностирования злокачественных опухолей, инфекционных заболеваний, заболеваний, требующих гормональной, лучевой, цитостатической терапии и хирургических вмешательств, патологогистологическое заключение не подписывает:

{

=Врач-патологоанатом

=Заведующий патологоанатомическим отделением

=Главный врач

=Лечащий онколог

=Врач-патологоанатом и заведующий патологоанатомическим отделением

}

Патологоанатомическая документация в рамках посмертной морфологической диагностики:

{

=Медицинская карта амбулаторного больного

=Корешки медицинских свидетельств о смерти

=Протокол патологоанатомического вскрытия

=Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших
=Амбулаторная карта больного
}

Патологоанатомическая документация в рамках прижизненной морфологической диагностики:

{
=Журнал архивации
=Журнал регистрации исследований
=Бланки направлений на патогистологическое исследование
=Журнал регистрации выдачи заключений
=Журнал хранения
}